内科含诊断 慢性肺心病 ★☆☆（0~1题）

- 缺氧致血管痉挛和重构→肺动脉高压（2020）
- 诊断
  - COPD/ 肺纤维化 / 慢纤空等（2023）
    P_2 亢进、右心功能不全
    可能可能最可能（2007）
    - 代偿期和失代偿期均可有：颈静脉怒张、三尖瓣区收缩期杂音、肝界下移
    - 仅失代偿期才可有：肝颈静脉回流征阳性、三尖瓣区舒张期杂音、肝大且压痛、双下肢水肿、腹水、呼衰
- 检查（2024）
  - X 线：右下肺动脉干增宽、肺动脉段凸出、心脏向左扩大、心尖圆隆上翘
  - 超声心动图：右心室前壁厚度≥ 5mm
  - 心电图：顺钟向转位、电轴右偏、RV1+SV5 ≥ 1.05、肺型 P 波（P 波≥ 0.25，右心房增大可有）
- 急性加重的治疗（2014、2017）
  - 关键：抗生素控制感染、改善呼吸、防治并发症
  - 小剂量
    - 不常规用利尿剂：可致呼酸合并代碱
    - 不常规用强心苷
      - 指征
        ①感染已控制、呼吸功能已改善、利尿治疗后右心功能无改善
        ②以右心衰为主要表现而无明显感染
        ③合并室上性快速型心律失常：室上性心动过速、房颤（心室率 >100 次 / 分）
        ④合并急性左心衰